

Isquemia mesentérica · dor desproporcional

Dor abdominal intensa com exame físico ainda pobre = pense isquemia mesentérica. Tempo é intestino: angiotomografia e revascularização/ressecção precoces.

Tipos

Lembre - Tipos

Embolia arterial (FA), trombose arterial (aterosclerose), não oclusiva/NOMI (choque, vasopressores) e trombose venosa mesentérica (trombofilia). Cada uma tem nuance terapêutica.

Janela estreita: quanto mais tarde o diagnóstico, maior a necrose e a sepse.



Conduta

- Ressuscitação, ATB se necrose/perfuração suspeita, anticoagulação quando indicada
- AngioTC mesentérica = exame de escolha no estável
- Embolia/trombose: cirurgia/endovascular para restaurar fluxo + avaliar vitalidade
- Ressecar apenas alças inviáveis; second-look frequente

Pistas etiológicas

Tipo | Pista

Embolia | FA, IAM, sopro; início súbito

Trombose arterial | Claudicação abdominal prévia / aterosclerose

NOMI | UTI, baixo débito, drogas vasoativas

Venosa | Trombofilia, pancreatectomia, hipertensão portal

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Lactato normal não exclui isquemia precoce. Dor desproporcional + FA = angioTC, não 'analgésico e observar' até peritonite.